

TEMA 7.3 • PSIQUIATRÍA GENERAL

Psiquiatría Infantil: Conducta y Trastornos del Comportamiento

PERFIL EUNACOM 1.05.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los problemas de comportamiento en la infancia son uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría y psiquiatría infantil. Es fundamental distinguir entre las crisis de desarrollo normales, los trastornos de la regulación emocional y las conductas francamente patológicas que vulneran los derechos de terceros.

1. Oposicionismo Normal del Lactante (Los "Terribles Dos")

No todo niño que se porta "mal" tiene una patología psiquiátrica. El oposicionismo en etapas tempranas es una manifestación del desarrollo normal.

- **Causa:** Es parte del **proceso de individuación**. La díada madre-hijo comienza a separarse y el niño busca lograr su autonomía.
- **Factores de riesgo:** Temperamento difícil desde lactante (sensibilidad a la ropa, dificultades para dormir o comer).
- **Clínica:** Típico en niños de **2 a 3 años**. Se manifiesta con rabietas, obstinación, llanto, gritos o tirarse al piso cuando no consiguen lo que quieren.
- **Manejo:**
 - Educación a los padres sobre la normalidad del cuadro.
 - Fomentar la **tolerancia a la frustración** (no ceder ante la rabieta).
 - Contención emocional y acompañamiento.
 - Mucha paciencia por parte de los cuidadores.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Desarrollo: El "No" del niño de dos años no es un ataque personal a los padres, sino una herramienta para autoafirmar su existencia como un ser independiente de sus cuidadores.

2. Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)

El TOD (*o Oppositional Defiant Disorder*) es un escalón más arriba en severidad y se presenta en niños un poco mayores.

- **Causa:** Combinación de temperamento difícil y pautas de crianza con disciplina ineficaz o inconsistente.
- **Clínica:**
 - Niños en edad **preescolar tardía (4-5 años) o escolar**.
 - **Insolencia** y desafío constante a la autoridad (padres, profesores).
 - Hostilidad y agresividad verbal (insultos).
 - Tendencia a hacer exactamente lo contrario a lo solicitado (oposicionismo activo).
 - Relación difícil con pares debido a la nula tolerancia a la frustración.
- **Manejo:**
 - Intervención sistémica (terapia familiar).
 - Entrenamiento en pautas de crianza para los padres.
 - Prevención del maltrato infantil (los padres suelen estar agotados y en riesgo de reaccionar violentamente).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El maltrato físico como respuesta a la conducta del niño con TOD solo perpetúa el ciclo de agresividad y empeora el pronóstico. Es vital intervenir en la salud mental de los cuidadores.

3. Trastorno de Conducta (Disocial)

Es la forma más grave de los trastornos del comportamiento y representa una transgresión de las normas sociales y los derechos de los demás.

- **Causa:** Fuerte asociación con ambientes de **alta vulnerabilidad**, familias disfuncionales, consumo de sustancias en el hogar y

exposición a delitos.

- **Clínica:**
 - Generalmente en escolares mayores o adolescentes.
 - **Violación de normas:** Mentiras frecuentes, robos, ausentismo escolar.
 - **Agresión:** Maltrato físico a personas o **crueledad con los animales** (esto último es un signo de alarma mayor).
 - **Destrucción de la propiedad:** Vandalismo, incendios provocados.
 - Falta de remordimiento o empatía.
- **Evolución:** Tiene un alto riesgo de evolucionar hacia un **Trastorno de Personalidad Antisocial** en la adultez.
- **Manejo:**
 - Intervención inmediata con enfoque sistémico y red de apoyo social.
 - En casos de vulnerabilidad extrema, puede requerir la separación del ambiente tóxico (ej. medidas de protección judicial).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si el caso clínico describe a un niño que disfruta haciendo daño a animales o que inicia incendios, el diagnóstico es **Trastorno de Conducta** (antes llamado Disocial), no simplemente oposicionismo.

Diagnóstico Diferencial

Es crucial no confundir estos trastornos con otras patologías que pueden manifestarse como irritabilidad o mala conducta.

TABLA 7.3.1: DIAGNÓSTICO VS CARACTERÍSTICAS CLAVE

DIAGNÓSTICO	CARACTERÍSTICAS CLAVE
Oposicionismo Normal	2-3 años, rabietas por autonomía, desarrollo normal.
TOD	Desafío a la autoridad, insolencia, pero sin violar derechos graves de terceros.
Trastorno de Conducta	Robos, crueldad animal, delincuencia, violación de derechos.
Depresión en Niños y Adolescentes	Cambio brusco en la conducta. El niño era "bueno" y de pronto está irritable y aislado.
Trastorno de Déficit Atencional (TDAH)	Desorden, impulsividad y romper cosas sin intención de desafiar o dañar. Niños "dulces" pero muy inquietos.

Casos Clínicos de Repaso

- **Niño de 2 años con rabietas:** Diagnóstico: **Normalidad** (Oposicionismo normal). Manejo: Educación y paciencia.
- **Niño de 5 años insolente que golpea a sus padres:** Diagnóstico: **Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD)**.
- **Niño de 12 años que cambia su conducta hace un mes, se encierra y grita:** Diagnóstico: Sospechar **Depresión Infantil** o trastorno del ánimo. Todo cambio brusco de conducta requiere evaluar factores estresantes (bullying, abuso, problemas familiares).
- **Niño de 13 años que roba, raya paredes y lanza piedras a perros:** Diagnóstico: **Trastorno de Conducta** (Disocial). Requiere intervención intensiva de red de apoyo.
- **Niña de 6 años que rompe cosas por desordenada, pero es cariñosa y no desafiante:** Diagnóstico: Sugiere **Trastorno de Déficit Atencional** con predominio hiperactivo.

EUNACOM CRITERIOS

Ante un niño con problemas de conducta, siempre se debe realizar un enfoque sistémico. La conducta del niño suele ser el síntoma de una disfunción en su entorno o de una patología de base no diagnosticada.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Madre trae a consulta a su hijo de 2 años y medio porque hace rabietas cuando no consigue lo que quiere, se tira al suelo y llora intensamente. La madre está muy angustiada porque cree que el niño tiene algún problema psiquiátrico. Al examen el niño está sano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Psiquiatría Infantil: Conducta y Trastornos del Comportamiento. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El oposicionismo normal ocurre entre los 2-3 años ("terribles dos") y se maneja con educación y tolerancia a la frustración.
- El TOD se caracteriza por actitud insolente, agresión a figuras de autoridad y hacer lo contrario a lo pedido de manera deliberada.
- El trastorno de conducta disocial incluye robo, mentiras, agresión a personas/animales y destrucción de propiedad, asociado a ambientes vulnerables.
- Un niño que cambia bruscamente de conducta (baja notas, se encierra, se vuelve insolente) obliga a descartar depresión, bullying o abuso.
- El trastorno de conducta sin intervención puede evolucionar a trastorno de personalidad antisocial en la adultez.
- La intervención sistémica (red de apoyo y familia) es fundamental en el trastorno de conducta; si el ambiente es tóxico puede requerir separación del niño.
- Un niño travieso que desordena pero no tiene actitud desafiante orienta más a TDA que a trastorno de conducta.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PSIQUIATRÍA INFANTIL: CONDUCTA Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO)**PREGUNTA 1**

Madre trae a consulta a su hijo de 2 años y medio porque hace rabietas cuando no consigue lo que quiere, se tira al suelo y llora intensamente. La madre está muy angustiada porque cree que el niño tiene algún problema psiquiátrico. Al examen el niño está sano. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Derivar a psiquiatra infantil por trastorno oposicionista desafiante
- B)** Iniciar risperidona para control de la agresividad
- C)** Educar a la madre sobre el oposicionismo normal y estrategias de manejo conductual
- D)** Solicitar evaluación neuropsicológica para descartar TEA
- E)** Derivar a evaluación por trastorno de conducta disocial

PREGUNTA 2

Niña de 13 años, antes descrita como tranquila y con buenas notas, presenta desde hace 3 semanas aislamiento, bajó sus calificaciones, se encierra en su pieza con portazos y le grita a su madre. Los padres consultan por "problemas de conducta". ¿Cuál es la primera evaluación que debe realizarse?

- A)** Evaluar por trastorno oposicionista desafiante y derivar a terapia conductual
- B)** Evaluar el estado anímico para descartar depresión, bullying o abuso
- C)** Diagnóstico de trastorno de conducta disocial e intervención sistémica
- D)** Iniciar metilfenidato por probable TDA de inicio tardío
- E)** Internación psiquiátrica de urgencia por riesgo conductual

PREGUNTA 3

Adolescente de 14 años es enviado por el colegio porque roba a sus compañeros, miente, ha sido visto maltratando perros en el barrio, reprobó varias asignaturas y destruyó material escolar. Vive con su madre quien consume alcohol habitualmente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta?

- A)** TOD; psicoterapia cognitivo-conductual ambulatoria
- B)** Trastorno de conducta disocial; intervención sistémica urgente y eventual cambio de ambiente
- C)** Esquizofrenia de inicio en la adolescencia; antipsicóticos
- D)** Depresión mayor con irritabilidad; antidepresivos ISRS
- E)** Trastorno por déficit atencional; metilfenidato

RESUMEN: PSIQUIATRÍA INFANTIL: CONDUCTA Y TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO

El comportamiento oposicionista en niños abarca un espectro que va desde lo normal hasta lo claramente patológico. El oposicionismo normal se relaciona con el proceso de individuación y autonomía del niño, típicamente entre los 2 y 3 años ("los terribles dos"), caracterizado por rabietas, obstinación y llanto cuando no se satisfacen sus deseos. El manejo es educativo, fomentando la tolerancia a la frustración y la paciencia de los padres. Un temperamento difícil desde lactante predispone a conductas más marcadas. El Trastorno Oposicionista Desafiante (TOD) se presenta en preescolares mayores y escolares (de 4 a 6 años en adelante) y se distingue del oposicionismo normal por la actitud abiertamente insolente e irrespetuosa: el niño insulta, agrede a figuras de autoridad, actúa deliberadamente de manera contraria a lo pedido y tiene baja tolerancia a la frustración. El conflicto principal es con la autoridad. El manejo sigue siendo educativo con límites consistentes, prevención del maltrato y eventualmente intervención sistémica familiar si existe disfunción familiar. El Trastorno de Conducta Disocial es el cuadro más grave, visto en escolares y adolescentes que presentan conductas activamente transgresoras: robo, mentiras, agresión a personas o animales, destrucción de propiedad e incumplimiento de normas éticas. Se asocia a ambientes de vulnerabilidad, consumo de sustancias en la familia y abandono. Sin intervención oportuna evoluciona al trastorno de personalidad antisocial en la adultez. La intervención debe ser sistémica, a menudo requiriendo sacar al niño del ambiente tóxico. Un cambio conductual brusco en un niño previamente sano obliga a descartar depresión, bullying o abuso.